

## Cambios fisiológicos del puerperio

---

### 1. Introducción y relevancia clínica

El **puerperio** o **periodo posparto** es el intervalo de tiempo que **sigue al parto** y se **extiende hasta que los órganos genitales y la fisiología materna retornan a su estado pregestacional**.

Tiene una duración aproximada de **6 semanas (42 días)** y constituye un período de **grandes adaptaciones hormonales, metabólicas, uterinas y emocionales**.

Durante este tiempo, la mujer se enfrenta a tres procesos simultáneos:

1. **Involución uterina y recuperación anatómica.**
2. **Inicio de la lactancia y regulación hormonal.**
3. **Ajuste cardiovascular, renal y emocional.**

□ En EUNACOM, el puerperio es fuente de preguntas clínicas sobre hemorragia, fiebre, subinvolución, cambios fisiológicos y lactancia.

---

### 2. Fases del puerperio

| Fase             | Duración      | Características principales                                                    |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inmediato</b> | Primeras 24 h | Control de sangrado y contractilidad uterina                                   |
| <b>Temprano</b>  | 2°–10° día    | Cambios hormonales y aparición de loquios                                      |
| <b>Tardío</b>    | 10°–42° día   | Recuperación completa del útero y retorno de la menstruación (en no lactantes) |

---

### 3. Fisiología general del puerperio

#### A.

##### Involución uterina

- Tras el parto, el útero pesa cerca de **1.000 g** y se reduce a **50–100 g** en 6 semanas.
- El fondo uterino, palpable a nivel umbilical inmediatamente posparto, **desciende 1–2 cm por día**, no siendo palpable abdominalmente al día 10.
- La involución se produce por **autólisis de fibras musculares y vasoconstricción**.

☐ La **oxitocina** liberada durante la lactancia favorece este proceso, produciendo las contracciones llamadas **entueritos** (más evidentes en multíparas).

---

#### B.

##### Loquios

Flujo vaginal fisiológico del puerperio, constituido por restos de sangre, decidua y secreción cervical.

| Tipo            | Apariencia                  | Duración aproximada |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| Loquios rubros  | Rojos, sanguinolentos       | 1–3 días            |
| Loquios serosos | Rosados o marrón claro      | 4–10 días           |
| Loquios alba    | Amarillentos o blanquecinos | 11–21 días          |

☐ Persistencia de loquios fétidos o hemáticos abundantes tras la segunda semana → sospechar **subinvolución o endometritis**.

---

#### C.

## Cuello uterino y vagina

- El cuello se encuentra **edematoso y entreabierto** tras el parto; recupera consistencia firme hacia el **día 7–10**.
  - El **orificio cervical externo** no vuelve a ser puntiforme (forma transversal en multíparas).
  - La mucosa vaginal y vulvar, al descender los estrógenos, presentan **sequedad, atrofia y menor lubricación** (más notorio si lactancia activa).
- 

## D.

## Mamas y lactancia

- Influenciada por **prolactina, oxitocina, estrógenos y progesterona**.
- La caída brusca de estrógenos y progesterona posparto permite la acción de la **prolactina** → producción de leche.
- **Oxitocina** estimula la eyección láctea mediante contracción de las células mioepiteliales.

□ El estímulo de succión mantiene los niveles de prolactina, **inhibiendo el eje gonadotrópico (FSH y LH)** → **amenorrea de la lactancia**.

---

## 4. Cambios hormonales y metabólicos

| Hormona                          | Cambio posparto        | Efecto                               |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estrógenos / progesterona</b> | Caída brusca           | Favorece lactogénesis                |
| <b>Prolactina</b>                | Aumenta (si lactancia) | Síntesis de leche                    |
| <b>Oxitocina</b>                 | Se libera con succión  | Eyección láctea e involución uterina |

FSH / LH

Inhibidas por prolactina    Amenorrea lactacional

Cortisol y hormonas  
tiroideas

Vuelven a niveles  
basales

Normalización metabólica

---

## 5. Cambios cardiovasculares y renales

- **Volumen plasmático:** disminuye 1–2 L por diuresis y sudoración.
- **Frecuencia cardíaca:** tiende a la normalidad en 2–3 días.
- **Leucocitosis leve:** fisiológica (hasta 20.000/mm<sup>3</sup>).
- **Diuresis posparto:** aumenta por pérdida de líquido retenido durante el embarazo.

☐ Si hay fiebre o taquicardia persistente → sospechar infección (endometritis o mastitis).

---

## 6. Cambios gastrointestinales

- **Atonía intestinal** por efecto de progesterona y analgesia → riesgo de constipación.
  - **Recomendaciones:** hidratación, fibra, movilización precoz.
- 

## 7. Cambios hematológicos

- **Hemoglobina y hematocrito:** tienden a aumentar si no hubo sangrado excesivo.
- **Coagulabilidad:** permanece aumentada durante 2 semanas → **riesgo de trombosis venosa profunda (TVP).**

→ Motivo por el cual se indica **movilización precoz y profilaxis en mujeres de riesgo.**

---

## 8. Cambios emocionales y psicológicos

| Trastorno                 | Inicio         | Características                                             | Conducta                                 |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>“Baby blues”</b>       | 3–5° día       | Labilidad emocional, llanto fácil, sin alteración funcional | Apoyo y contención; remite en <2 semanas |
| <b>Depresión posparto</b> | 2–6 semanas    | Tristeza persistente, anhedonia, insomnio, culpa            | Derivación y tratamiento farmacológico   |
| <b>Psicosis puerperal</b> | Días a semanas | Delirios, alucinaciones, riesgo suicida                     | Urgencia psiquiátrica                    |

□ El “baby blues” es muy frecuente (hasta 60%) y autolimitado; su confusión con depresión posparto es un error común en EUNACOM.

---

## 9. Examen clínico posparto (control puerperal)

### A.

#### Puerperio inmediato (primeras 24 h)

- Control de sangrado vaginal (debe ser moderado, no abundante).
  - Palpación de fondo uterino (firme, a nivel umbilical).
  - Control de signos vitales cada 4 h.
  - Valoración de diuresis y temperatura.
  - Iniciar lactancia precoz y oxitocina posparto (10 UI EV o IM).
- 

### B.

#### Puerperio temprano (días 2–10)

- Vigilar loquios (color, olor).
- Revisar heridas quirúrgicas o perineales.
- Educar sobre signos de alarma (fiebre, sangrado, dolor pélvico).
- Aconsejar alimentación y descanso.

---

## C.

### Puerperio tardío (2–6 semanas)

- Evaluar involución uterina y peso.
  - Revisión mamaria y técnica de lactancia.
  - Orientar anticoncepción.
  - Control emocional y pesquisa de depresión posparto.
- 

## 10. Anticoncepción en el puerperio

| Método                                                 | Inicio                                                  | Observaciones                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Lactancia exclusiva (MELA)</b>                      | Inmediato                                               | Eficacia 98% si <6 meses, amenorrea y lactancia exclusiva |
| <b>Progestinas (minipíldora, implante, inyectable)</b> | Desde 6 semanas (o antes si no lacta)                   | No afectan producción láctea                              |
| <b>DIU</b>                                             | 6–8 semanas posparto o inmediata postparto (según guía) | Evaluar involución uterina                                |

**Anticonceptivos combinados (estrógeno + progestina)**

A partir de 6 meses o cuando suspenda lactancia

Riesgo trombótico si antes

☐ EUNACOM suele preguntar: “Método más seguro en puerperio con lactancia: **progestina sola o DIU.**”

---

## 11. Signos de alarma durante el puerperio

- Fiebre  $>38^{\circ}\text{C}$  después de las primeras 24 h.
- Loquios fétidos o purulentos.
- Sangrado abundante o persistente.
- Dolor abdominal intenso o útero blando (subinvolución).
- Disuria o dolor mamario.
- Tristeza o ansiedad severa.

**Sospechas principales:**

- **Endometritis.**
  - **Mastitis.**
  - **Hemorragia posparto secundaria.**
  - **Tromboflebitis pélvica.**
- 

## 12. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐

**Perlas**

1. El puerperio dura **6 semanas** y se divide en tres fases: inmediato, temprano y tardío.
2. La **involución uterina** normal implica descenso diario del fondo ( $\approx 1-2$  cm/día).
3. **Loquios normales**: transición rubros  $\rightarrow$  serosos  $\rightarrow$  alba.
4. **Amenorrea lactacional**: efecto de la prolactina sobre FSH/LH.
5. **“Baby blues”** es fisiológico; la depresión posparto no.
6. **Movilización precoz** previene TVP.
7. **Anticoncepción segura**: progestina sola o DIU.



### Errores comunes

- Considerar fisiológico un sangrado abundante tras el día 7.
- No diferenciar baby blues de depresión posparto.
- Iniciar anticonceptivos combinados antes de 6 semanas.
- Omitir control uterino y loquios en el puerperio inmediato.
- No administrar oxitocina tras el parto.

---

## 13. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Puerperio**: periodo de 6 semanas para la recuperación anatómica y funcional posparto.
2. **Involución uterina**: fondo desciende 1–2 cm/día; no palpable al día 10.
3. **Loquios normales**: rubros  $\rightarrow$  serosos  $\rightarrow$  alba.
4. **Prolactina y oxitocina**: responsables de la lactancia y la amenorrea.
5. **“Baby blues”**: autolimitado, no patológico; **depresión posparto** requiere tratamiento.



6. **Anticoncepción:** progestina o DIU son los métodos de elección.
7. **Fiebre, sangrado o loquios fétidos** son signos de alarma de infección puerperal.